KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Choque

Aula 5 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Choque

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Reconhecer e abordar os tipos de choque.

O choque é uma falência circulatória que não entrega oxigénio suficiente aos tecidos. Reconhecê-lo cedo e tratar a causa salva vidas. Nesta aula aprende os tipos de choque, os sinais, as primeiras acções e três situações frequentes: hemorragia, sépsis e anafilaxia.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. O que é o choque
3. Os quatro tipos de choque
4. Sinais gerais de choque
5. Pistas para identificar o tipo
6. Primeiras acções
7. Choque hemorrágico: classes
8. Sépsis e choque séptico
9. Anafilaxia
10. Caso clínico: acidente de mota
11. Caso clínico: resolução
12. Erros frequentes
13. Pontos-chave
14. Para reflectir
15. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Definir choque e explicar porque a hipotensão é um sinal tardio
2. Distinguir os quatro tipos de choque
3. Reconhecer os sinais gerais e as pistas de cada tipo
4. Aplicar as primeiras acções, em sequência
5. Reconhecer hemorragia grave, sépsis e anafilaxia

O que é o choque

O choque é um estado de **perfusão insuficiente**: o sangue não leva oxigénio suficiente aos órgãos. Se não for corrigido, as células sofrem, os órgãos falham e o doente morre.

- A causa pode ser falta de volume, falha da bomba, vasodilatação ou obstrução
- Não é sinónimo de tensão arterial baixa
- Quanto mais cedo se reconhece e se trata a causa, melhor o resultado

> A tensão arterial pode manter-se normal durante muito tempo, porque o corpo compensa. Quando cai, o choque já está avançado.

Os quatro tipos de choque

Tipo	Mecanismo	Exemplos
Hipovolémico	Perda de volume	Hemorragia, desidratação, queimaduras
Cardiogénico	Falência da bomba	Enfarte, arritmia, insuficiência cardíaca
Distributivo	Vasodilatação	Sépsis, anafilaxia, lesão medular
Obstrutivo	Obstrução ao fluxo	Pneumotórax hipertensivo, tamponamento, embolia pulmonar



Sinais gerais de choque

- Taquicardia e taquipneia
- Pele fria e pegajosa (ou quente e vermelha no choque séptico inicial)
- Enchimento capilar superior a 2 segundos
- Agitação, confusão ou sonolência
- Diurese baixa (menos de 0,5 mL/kg/h)
- Hipotensão: sinal **tardio**

> Jovens, crianças e grávidas compensam durante muito tempo e depois descompensam depressa. Não espere pela hipotensão.

Pistas para identificar o tipo

Tipo	Pistas
Hipovolémico	Pele pálida e fria, veias do pescoço colapsadas, perda visível ou história de vómitos e diarreia
Cardiogénico	Dor no peito, crepitações nos pulmões, veias do pescoço distendidas
Séptico	Febre, foco de infecção, pele quente e vermelha ao início
Anafilático	Urticária, inchaço da face, sibilos ou estridor depois de exposição
Obstrutivo	Dispneia súbita, trauma torácico, assimetria dos sons respiratórios

Primeiras acções

Pedir ajuda

avise o médico e a equipa de emergência

Oxigénio

se indicado, e monitorização contínua

Acesso venoso

dois acessos, e colheitas de sangue

Fluidos e fármacos

segundo a causa e a prescrição

Tratar a causa

parar a hemorragia, antibiótico, adrenalina, drenagem

Choque hemorrágico: classes

Classe	Perda de sangue	Pulso	Tensão arterial
I	Até 15% (< 750 mL)	Normal	Normal
II	15 a 30% (750 a 1500 mL)	100 a 120	Normal
III	30 a 40% (1500 a 2000 mL)	120 a 140	Baixa
IV	Mais de 40% (> 2000 mL)	Mais de 140	Muito baixa

- Controle a hemorragia externa com **compressão directa**
- Previna a hipotermia: aumenta a mortalidade

> Valores para um adulto de 70 kg; mudam com a idade, a medicação e as doenças prévias.

Sépsis e choque séptico

Sépsis é a disfunção de órgãos causada por uma resposta anormal do corpo a uma infecção.

- Suspeite perante infecção com febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, confusão ou hipotensão
- Aja **na primeira hora**: avise o médico, colha hemoculturas e lactato, administre o antibiótico prescrito sem atraso e fluidos prescritos
- Monitorize a diurese e reavalie com frequência

> Cada hora de atraso no antibiótico aumenta o risco de morte no choque séptico.

Anafilaxia

Reacção alérgica grave, de início rápido, com compromisso da via aérea, da respiração ou da circulação.

- Retire o agente causador, se possível, e peça ajuda
- **Adrenalina intramuscular** na face externa da coxa, segundo o protocolo (dose habitual no adulto: 0,5 mg, isto é, 0,5 mL da solução de 1 mg/mL)
- Oxigénio em alto fluxo; deite o doente com as pernas elevadas (sente-o se tiver dificuldade em respirar)
- Fluidos em bólus prescritos; repita a adrenalina passados 5 minutos se não melhorar

Caso clínico: acidente de mota

Rapaz de 22 anos, vítima de acidente de mota há 30 minutos. Está pálido, ansioso e com dor abdominal.

- Pulso: 130 por minuto; tensão arterial: 90/60 mmHg
- Frequência respiratória: 28 por minuto
- Pele fria e suada; ferida aberta na coxa a sangrar

Pense antes de avançar: que tipo de choque? Quais são as primeiras acções?

Caso clínico: resolução

- **Choque hemorrágico**, pelo menos classe III (pulso acima de 120 e tensão a baixar)
- Peça ajuda e avise a cirurgia; compressão directa da hemorragia da coxa
- Oxigénio, dois acessos de calibre largo, colheitas (incluindo grupo sanguíneo)
- Fluidos e hemoderivados segundo a prescrição, com reavaliação frequente
- Cubra o doente e evite a hipotermia

> A hemorragia interna (abdómen) só se resolve com tratamento definitivo: **não atrase a transferência** para cirurgia.

Erros frequentes

- Esperar pela hipotensão para actuar
- Dar fluidos sem reavaliar depois de cada bólus
- Esquecer o controlo da hemorragia externa
- Deixar o doente a arrefecer
- Tratar só os sinais e não procurar a causa
- Demorar a pedir ajuda

Pontos-chave

1. O choque é perfusão insuficiente; a hipotensão é tardia
2. Quatro tipos: hipovolémico, cardiogénico, distributivo, obstrutivo
3. Primeiro, peça ajuda; depois ABCDE
4. Controle a hemorragia com compressão directa
5. Sépsis: aja na primeira hora
6. Anafilaxia: adrenalina intramuscular sem demora

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Que doentes do seu serviço têm mais risco de choque?

? Que material de emergência deve estar sempre completo e onde está?

? Como explicaria à família que o doente está em choque?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Avaliação primária ABCDE

→ NEWS2: escala de alerta precoce

→ Sinais vitais: valores de referência no adulto

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser